

## CUERPO EXTRAÑO OCULAR

*Carlos Plaza Laguardia, Marta Cuesta Lasso, Álvaro Rodríguez Castelblanco.*

### INTRODUCCIÓN

El cuerpo extraño (CE) ocular es una causa muy frecuente de consulta sanitaria urgente. En la gran mayoría de los casos se encuentran a nivel superficial, ya sea incrustados en las capas superficiales de la córnea o en la conjuntiva, sin embargo, resulta de vital importancia descartar la presencia de un cuerpo extraño intraocular (CEIO) mediante una adecuada anamnesis y exploración física, ya que este diagnóstico implica un mal pronóstico que empeora rápidamente con el paso de las horas.

### DIAGNÓSTICO

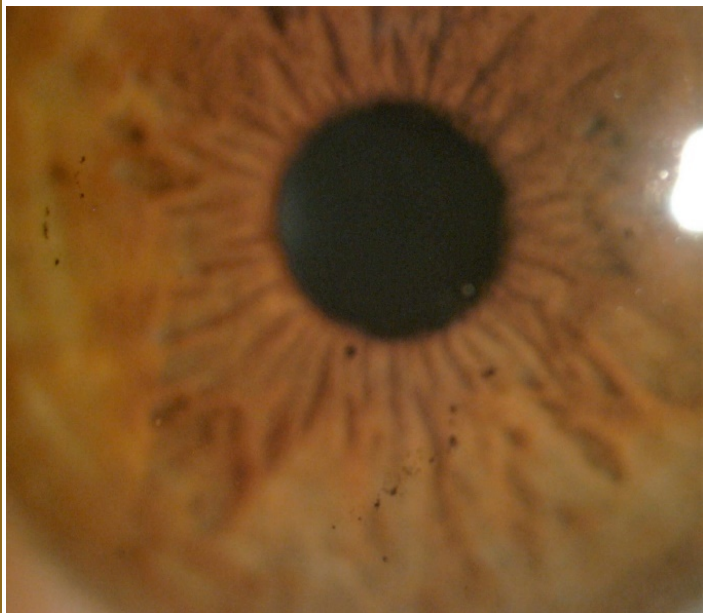
La realización de una anamnesis adecuada es clave. El paciente suele referir actividades previas que orientan el diagnóstico, siendo especialmente frecuente el haber estado trabajando con herramientas de construcción (radial, martillo, cincel, taladradora etc...).

La exploración debe comenzar por documentar la agudeza visual. Para ello se suele requerir la instilación de anestésico tópico para el control del dolor y el blefaroespasma. A continuación, idealmente con la ayuda de una lámpara de hendidura, debe ser explorada la superficie ocular al completo: la córnea y la conjuntiva. Es necesario evertir los párpados para la visualización de la porción tarsal conjuntival, así como para descartar la presencia de cuerpos extraños a nivel de los fórnices, donde, por efecto del barrido palpebral, pueden ir a parar algunos cuerpos extraños superficiales.

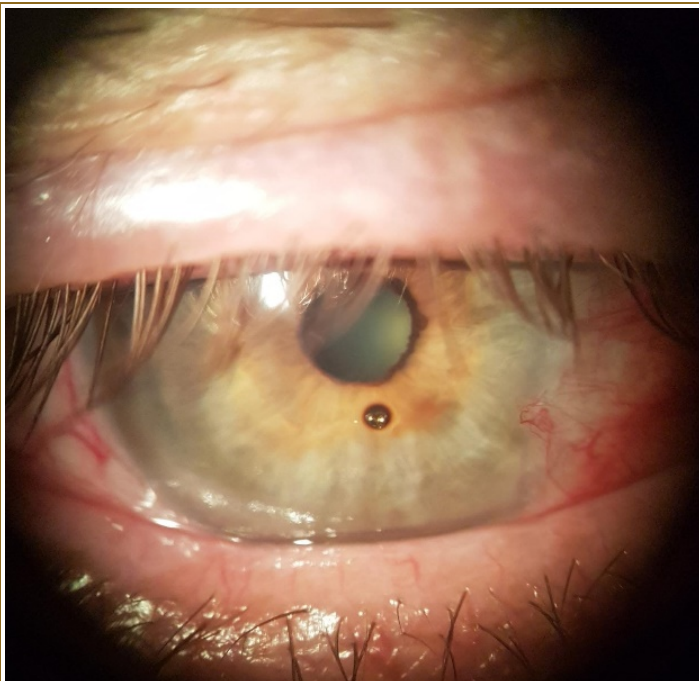
Existen ciertos signos característicos que deben alertar de la posible presencia de un cuerpo extraño intraocular como son: laceración de espesor completo autosellada, desgarro iridiano, sangrado en cámara anterior, opacidad cristalina o presión intraocular baja. Otras exploraciones útiles para descartar la presencia de un objeto en el interior del globo ocular son la exploración del polo posterior bajo midriasis farmacológica, la ecografía o la tomografía axial computarizada orbitaria.

### TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Cuerpo extraño corneal de espesor parcial o conjuntival.



Cuerpo extraño corneal con halo de herrumbre.

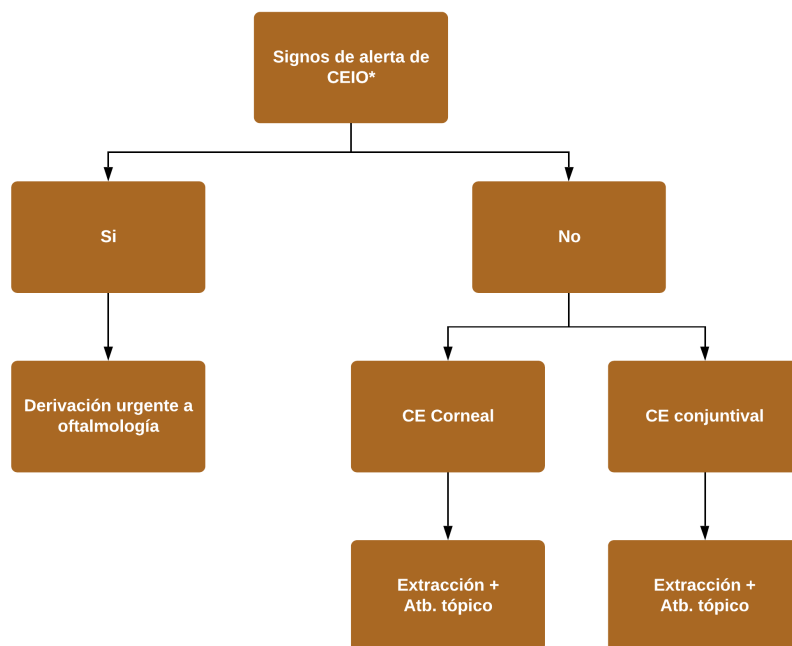


Pigmentación corneal secundaria a estallido de un tubo de escape. Sin afectación clínica, el paciente no precisó la extirpación de los diminutos cuerpos extraños.

### Procedimiento

- Instilar una gota de anestésico local (lidocaína).
- Se puede intentar la extracción mediante una hemosteta o un algodón húmedo. Es frecuente que esta maniobra no sea suficiente por lo que se debe emplear otra herramienta como una lanceta para cuerpos extraños, unas pinzas o una aguja fina. Raspar con delicadeza hasta obtener el cuerpo extraño y el halo de óxido circundante. En ocasiones es más seguro dejar dicho halo de herrumbre si se encuentra profundo ya que en unos días migrará a la superficie.
- Administrar una gota de fluoresceína al 2% para descartar el signo de Seidel bajo iluminación con luz azul cobalto. Si se observa fluido que lava el contraste a través de la lesión indica perforación ocular, en cuyo caso el paciente deberá ser referido urgentemente al oftalmólogo.
- Tratar la úlcera/laceración resultante con antibiótico (Atb) tópico (fluoroquinolona cuatro veces

al día durante una semana). En caso de irritación pueden administrarse lágrimas artificiales.



\*Laceración autosellada, alteración de la simetría pupilar, defecto en el cristalino, hipema, aplanamiento de la cámara anterior o presión intraocular baja unilateral

### BIBLIOGRAFÍA:

- Gerstenblith AT and Rabinowitz MP. The wills eye manual: office and emergency room diagnosis and treatment of eye disease. Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
- Kanski JJ and Bowling B. Oftalmología clínica 7ª Edición, Mosby Barcelona 1996
- Loporchio D et al. Intraocular foreign bodies: a review. Survey of ophthalmology. 2016; 61.5:582-596.